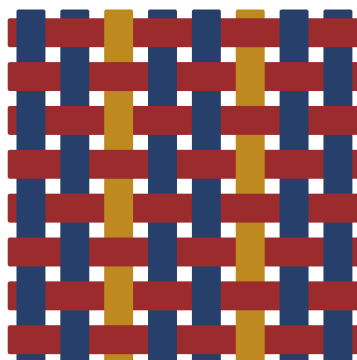




化验单分析课堂病例

主观题四句模板笔记 • NovaForge 视觉重排版

Codex

2026-06-30

dyed in indigo, madder & weld; ruled in iron-gall. woven on LOOM.

CONTENTS

1	化验单分析课堂病例：主观题四句模板笔记	2
1.1	0. 主观题固定答题骨架	2
1.2	1. 15 个课堂病例四句模板	2
1.2.1	例 1 小细胞低色素贫血：钩虫相关缺铁性贫血	2
1.2.2	例 2 白细胞明显增高：社区获得性肺炎 + 粒细胞类白血病反应	2
1.2.3	例 3 血小板减少：免疫性血小板减少症（ITP）	3
1.2.4	例 4 脑脊液异常：按 PPT 答案考虑化脓性脑膜炎	3
1.2.5	例 5 肝病黄疸 + 腹水：乙肝肝硬化失代偿期，伴原发性肝癌可能	3
1.2.6	例 6 柏油样便 + 隐血阳性：上消化道出血，十二指肠球部溃疡可能	4
1.2.7	例 7 高血糖 + 尿酮：糖尿病酮症酸中毒（DKA）	4
1.2.8	例 8 肌酐假性增高：Jaffé 法受硝基甲烷干扰	4
1.2.9	例 9 慢性肾炎：尿毒症 + 肾性贫血 + 蛋白尿	4
1.2.10	例 10 心肌标志物：急性广泛前壁心肌梗死	5
1.2.11	例 11 血气分析：重症哮喘由急性呼碱转急性呼酸	5
1.2.12	例 12 自身免疫：系统性红斑狼疮	5
1.2.13	例 13 肿瘤标志物：胰腺癌可能	6
1.2.14	例 14 甲状腺功能：甲状腺功能亢进症	6
1.2.15	例 15 微生物培养 + 血药浓度监测：MRSA 肺炎，万古霉素谷浓度偏高并肾损害	6
1.3	2. 高频检验组合速记	6
1.4	3. 最后 20 分钟背诵版	7

■ 1 化验单分析课堂病例：主观题四句模板笔记

来源：学校课堂 PPT《化验单分析汇总 0420》。

用法：专门服务主观病例分析题。每个病例按“诊断句 + 依据句 + 鉴别句 + 补充检查句”整理，尽量写成考场能直接搬的句子。

原则：课堂 PPT 已给出的结论优先；PPT 未展开的鉴别点，以实验诊断常用鉴别思路补足，并标注“PPT 未展开”。

1.1 0. 主观题固定答题骨架 遇到化验单病例，按这个顺序写：

1. 诊断句：本例首先考虑.....；同时考虑.....。
2. 依据句：依据为病史/体征提示.....，实验室检查见.....升高/降低/阳性，提示.....。
3. 鉴别句：需与.....鉴别，主要看.....。
4. 补充检查句：建议完善.....以明确诊断/病因/严重程度/并发症。

考场不要只写疾病名。最少也要写出：

本例考虑 _____。
依据为 _____；实验室检查 _____，提示 _____。
需与 _____ 鉴别，鉴别点为 _____。
建议完善 _____。

1.2 1. 15 个课堂病例四句模板

例 1 小细胞低色素贫血：钩虫相关缺铁性贫血 【题干速记】男，10 岁，面色苍白、疲乏无力半年，偏食。血常规：RBC $2.6 \times 10^{12}/L$ ，Hb 54 g/L，MCV 70 fL，MCH 24 pg，MCHC 280 g/L，PLT $220 \times 10^9/L$ ，网织红细胞 3.0%。血涂片：红细胞体积小、大小不等、中心淡染区扩大。大便 OB(+)，钩虫卵 (+)。

【诊断句】本例考虑小细胞低色素性贫血，病因考虑钩虫导致慢性失血所致缺铁性贫血；Hb 54 g/L，属重度贫血。

【依据句】患儿面色苍白、乏力，RBC $2.6 \times 10^{12}/L$ 、Hb 54 g/L 降低，MCV 70 fL、MCH 24 pg、MCHC 280 g/L 均降低，血涂片见红细胞体积小、大小不等、中心淡染区扩大；大便 OB(+) 且钩虫卵 (+) 支持慢性失血和缺铁。

【鉴别句】需与地中海贫血、慢性病性贫血、铁粒幼细胞性贫血鉴别；缺铁性贫血以血清铁、铁蛋白、转铁蛋白饱和度降低和总铁结合力升高为支持点，地中海贫血常有家族史及靶形红细胞，慢性病性贫血常铁蛋白不低。

【补充检查句】建议完善血清铁、铁蛋白、转铁蛋白饱和度、总铁结合力，必要时查骨髓象及骨髓铁染色；同时复查粪便虫卵和隐血以明确失血来源。

易漏得分点：贫血程度要写“重度”；形态学诊断和病因诊断要分开写。

例 2 白细胞明显增高：社区获得性肺炎 + 粒细胞类白血病反应 【题干速记】男，20 岁，高热咳嗽 1 周，咳少量脓痰。T 39.5℃，右下肺少量湿啰音。血常规：WBC $49.4 \times 10^9/L$ ，RBC $4.2 \times 10^{12}/L$ ，Hb 125 g/L，PLT $225 \times 10^9/L$ 。血涂片：中性分叶核 75%，杆状核 10%，晚幼粒 2%，中性粒细胞胞浆可见粗大蓝黑色中毒颗粒。胸片：右下肺炎。

【诊断句】本例考虑社区获得性肺炎，并出现粒细胞类白血病反应。

【依据句】患者高热、咳嗽咳痰，右下肺湿啰音，胸片提示右下肺炎；血常规 WBC $49.4 \times 10^9/L$ 明显升高，中性粒细胞为主，杆状核及晚幼粒细胞出现，提示核左移；中性粒细胞胞浆见中毒颗粒，支持严重感染反应。

【鉴别句】需与慢性粒细胞白血病鉴别。类白血病反应通常有明确感染等诱因，红细胞和血小板基本正常，中毒颗粒明显，原发病控制后血象可恢复；慢粒需结合骨髓象、白细胞碱性磷酸酶积分及 BCR-ABL 等检查鉴别。

【补充检查句】建议完善感染相关检查、病原学检查、炎症指标、胸部影像复查；若白细胞持续显著升高或出现幼稚细胞，应完善骨髓检查、白细胞碱性磷酸酶积分及相关分子检测。

易漏得分点：不要只写“肺炎”，要把“白细胞显著升高 + 核左移 + 中毒颗粒”写成实验室依据。

例 3 血小板减少：免疫性血小板减少症（ITP）【题干速记】女，27 岁，双下肢散在瘀点 5 天，压之不褪色，肝脾肋下未扪及。血常规：WBC $8.69 \times 10^9/L$ ，RBC $4.6 \times 10^{12}/L$ ，Hb 136 g/L，PLT $5 \times 10^9/L$ ，网织红细胞 1.51%。

【诊断句】本例考虑免疫性血小板减少症（ITP）。

【依据句】患者双下肢散在出血点，压之不褪色，肝脾不大；血常规 WBC、RBC、Hb 基本正常，而 PLT 仅 $5 \times 10^9/L$ ，提示重度血小板减少，以孤立性血小板减少为主要异常。

【鉴别句】需与再生障碍性贫血、白血病、DIC、脾功能亢进、继发性自身免疫病相关血小板减少鉴别；ITP 通常表现为血小板减少而其他血细胞形态无明显异常，脾脏一般不大，骨髓巨核细胞增多或正常但成熟障碍。

【补充检查句】建议复查血常规确认血小板减少，完善血小板相关抗体、凝血常规、腹部 B 超、抗核抗体、抗 ENA 抗体、骨髓形态及骨髓活检，以排除继发性血小板减少。

易漏得分点：写“血小板减少”不够，要写“孤立性血小板减少 + 出血表现 + 脾不大”。

例 4 脑脊液异常：按 PPT 答案考虑化脓性脑膜炎【题干速记】男，35 岁，发热伴头痛半月，呕吐 1 天。外院血常规：WBC $19.62 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 $16.05 \times 10^9/L$ ，Hb 147 g/L，PLT $233 \times 10^9/L$ 。脑脊液压力 380 mmH₂O；脑脊液常规、生化具体表格为 PPT 图片，略。

【诊断句】按课堂 PPT 答案，本例考虑化脓性脑膜炎。

【依据句】患者发热、头痛、呕吐，外周血 WBC $19.62 \times 10^9/L$ 、中性粒细胞升高；脑脊液压力明显增高，白细胞计数增多，蛋白升高，糖降低，提示中枢神经系统感染。

【鉴别句】需与结核性脑膜炎、病毒性脑膜炎鉴别。化脓性脑膜炎通常以中性粒细胞增多、糖明显降低、蛋白升高为特点；结核性脑膜炎常糖和氯化物降低、蛋白升高且淋巴细胞为主；病毒性脑膜炎糖多正常、蛋白轻中度升高。注意：PPT 病例中写到单核细胞比例高，考试若遇类似数据，应结合老师给出的答案和培养结果判断。

【补充检查句】建议完善脑脊液直接涂片、离心沉淀物涂片、脑脊液培养及药敏，必要时结合血培养和病原学检测以明确病因。

易漏得分点：脑脊液题要固定写“压力、细胞数、蛋白、糖、氯化物、涂片/培养”。

例 5 肝病黄疸 + 腹水：乙肝肝硬化失代偿期，伴原发性肝癌可能【题干速记】男，65 岁，腹胀乏力 2 年、尿黄 2 周。查体：肝病面容，皮肤巩膜黄染，蜘蛛痣、肝掌，腹部膨隆、移动性浊音(+)，肝脾肿大，下肢水肿。肝功：ALT 213、AST 169、TBIL 53.1、DBIL 25.4、ALB 22.5、A/G 0.85。乙肝两对半：HBsAg(+)、HBeAg(+)、HBcAb(+). AFP 650 μg/L。腹水：黄色澄清，比重 1.012，Rivalta(-)，蛋白 18 g/L，细胞数 $50 \times 10^6/L$ 。

【诊断句】本例考虑乙型肝炎肝硬化失代偿期，合并肝细胞性黄疸和漏出性腹水；同时考虑原发性肝癌可能，并有慢性乙型病毒性肝炎活动证据。

【依据句】患者腹胀、乏力、尿黄，查体有肝病面容、黄疸、蜘蛛痣、肝掌、肝脾肿大、移动性浊音阳性；ALT 213 IU/L、AST 169 IU/L 升高，TBIL 53.1 μmol/L、DBIL 25.4 μmol/L 升高，白蛋白 22.5 g/L 降低、A/G 0.85，提示肝功能损害和肝细胞性黄疸；腹水黄色澄清、比重 1.012、Rivalta 阴性、蛋白 18 g/L、细胞数 $50 \times 10^6/L$ ，符合漏出液；乙肝两对半 HBsAg(+)、HBeAg(+)、HBcAb(+) 支持乙肝感染复制；AFP 650 μg/L 支持肝癌可能。

【鉴别句】黄疸需与溶血性黄疸、胆汁淤积性黄疸鉴别：肝细胞性黄疸常见 ALT/AST 明显升高、结合与非结合胆红素均可升高、白蛋白下降；腹水需与结核性、肿瘤性、感染性渗出液鉴别，漏出液多见于门脉高压和低蛋白血症，渗出液则多比重高、蛋白高、细胞数高、Rivalta 阳性。

【补充检查句】建议完善肝胆脾胰 B 超、肝脏增强 CT/MRI、胃镜评估食管胃底静脉曲张，必要时行肝穿刺、腹腔镜或腹水细胞学/病原学检查以明确肿瘤和腹水病因。

易漏得分点：这一题要同时答“黄疸类型、腹水性质、可能诊断”。AFP >300 μg/L 是 PPT 强调点。

例 6 柏油样便 + 隐血阳性：上消化道出血，十二指肠球部溃疡可能 【题干速记】男，26 岁，上腹隐痛 2 月、柏油样便 2 天。疼痛位于剑突下及右上腹，多于餐前及夜间发作，进食后缓解。贫血貌。血常规：RBC $2.9 \times 10^{12}/L$ ，Hb 90 g/L，MCV 70 fL，MCH 24 pg，MCHC 280 g/L。粪便隐血(+++)。

【诊断句】本例考虑上消化道出血，病因考虑十二指肠球部溃疡可能。

【依据句】患者青年男性，反复上腹隐痛，以空腹痛和夜间痛为主，进食后缓解；出现柏油样便，粪便隐血(+++)；Hb 90 g/L，RBC $2.9 \times 10^{12}/L$ ，MCV/MCH/MCHC 降低，提示失血相关贫血。

【鉴别句】需与饮食或药物导致黑便、胃溃疡、胃癌、食管胃底静脉曲张破裂出血等鉴别；真正上消化道出血支持点为柏油样便、粪便隐血阳性和贫血，十二指肠溃疡支持点为空腹痛、夜间痛、进食缓解。

【补充检查句】建议行胃镜检查以明确出血部位和溃疡性质，必要时完善幽门螺杆菌检测、复查血常规和粪便隐血。

易漏得分点：粪便隐血阳性提示消化道微量出血，PPT 强调出血量 >5 mL 可阳性。

例 7 高血糖 + 尿酮：糖尿病酮症酸中毒 (DKA) 【题干速记】男，12 岁，口干、消瘦、多饮多尿 1 年，伴神志不清 2 小时。实验室检查：FBG 33.6 mmol/L，HbA1c 12.2%，尿酮(+++)，尿蛋白(±)。

【诊断句】本例考虑糖尿病，合并糖尿病酮症酸中毒。

【依据句】患儿口干、消瘦、多饮多尿并出现神志不清；FBG 33.6 mmol/L、HbA1c 12.2% 明显升高，尿酮(+++)，符合糖尿病及酮症；若伴 AG 增高型代谢性酸中毒，则支持 DKA。

【鉴别句】需鉴别 1 型与 2 型糖尿病，并与其他高血糖危象、乳酸酸中毒等鉴别。1 型糖尿病可通过胰岛素、C 肽降低及胰岛相关自身抗体阳性支持；DKA 的关键组合是高血糖、酮血症/酮尿、AG 增高型代谢性酸中毒。

【补充检查句】建议完善血气分析、AG、电解质、乳酸、肾功能、尿蛋白、血脂，以及胰岛素、C 肽和胰岛素自身抗体、胰岛细胞抗体、GAD 抗体、IA-2 抗体等。

易漏得分点：只写“糖尿病”不够，看到神志改变 + 尿酮(+++) 要写“酮症酸中毒可能”，但酸中毒需血气/AG 支持。

例 8 肌酐假性增高：Jaffé 法受硝基甲烷干扰 【题干速记】男，7 岁，严重恶心呕吐 1 天；1 天前误喝装在运动饮料瓶中的赛车燃料油，体格检查正常。检验结果为 PPT 图片，略；课堂答案提示血清肌酐明显增高。

【诊断句】本例考虑血清肌酐假性增高，而非真正严重肾功能衰竭。

【依据句】患儿误服赛车燃料油后 Cr 明显升高，似乎提示 GFR 下降；但与严重肾功能失调常见伴随异常不一致，如尿素、K⁺ 未明显升高，HCO₃⁻ 未降低，体格检查也无明显肾衰表现，提示检测干扰可能。

【鉴别句】需与真正急性肾损伤鉴别。真正肾损伤可见 Cr 与 BUN 同步升高，伴少尿、电解质紊乱、酸中毒或尿检异常；本例孤立性 Cr 明显升高且有硝基甲烷暴露史，支持 Jaffé 法肌酐测定受干扰。

【补充检查句】建议改用特异性较高的酶法复测血清肌酐，并复查尿素氮、电解质、HCO₃⁻、尿常规和 eGFR，以确认是否为假性升高。

易漏得分点：这题考“检验方法学干扰”，不要机械把 Cr 高等同于肾衰。

例 9 慢性肾炎：尿毒症 + 肾性贫血 + 蛋白尿 【题干速记】女，26 岁，面部水肿、镜下血尿和蛋白尿 2 年，既往慢性肾炎 2 年；近 1 月未限盐且饮水偏多，水肿加重、尿少。BP 140/100 mmHg，眼睑颜面水肿，双下肢凹陷性水肿。尿蛋白(+++)，尿 RBC 20/HP；Hb 70 g/L，BUN 21 mmol/L，Cr 450 μmol/L；肾脏超声示双肾缩小、皮质变薄、皮髓质界限不清。

【诊断句】本例考虑慢性肾小球肾炎进展，出现尿毒症、肾性贫血，并伴高血压和蛋白尿。

【依据句】患者既往慢性肾炎 2 年，现水肿加重、尿少、血压 140/100 mmHg；尿蛋白(+++)、尿红细胞 20/HP，提示肾小球源性尿异常；Hb 70 g/L 降低提示贫血；BUN 21 mmol/L、Cr 450 μmol/L 明显升高，肾脏超声示双肾缩小、皮质变薄、皮髓质界限不清，支持慢性肾功能不全。

【鉴别句】需与急性肾损伤、肾病综合征、肾前性少尿、泌尿系感染或结石相关血尿鉴别。慢性肾衰支持点为长期肾炎病史、双肾缩小、贫血、BUN/Cr 升高；肾小球性蛋白尿支持点为蛋白尿合并血尿和肾脏病史。

【补充检查句】建议完善 eGFR、尿蛋白定量、尿沉渣红细胞形态、血电解质、酸碱状态、肾性贫血相关检查和肾脏超声随访，必要时结合免疫学指标或肾脏专科评估病因。

易漏得分点：蛋白尿原因要写“肾小球滤过膜损伤/慢性肾小球肾炎所致”，不是只写“既往肾病”。

例 10 心肌标志物：急性广泛前壁心肌梗死 【题干速记】男，55 岁，吸烟 30 余年。既往劳力后胸闷胸痛，休息可缓解；1 天前胸痛明显加重，伴大汗、乏力，持续不缓解。心电图：V1-V5 ST 段弓背向上抬高，Q 波形成，T 波倒置。心超：左室前壁、前间壁运动减弱，左心功能减低。生化：CK-MB 111 ng/mL，TnT 2348 pg/mL，CK 211 U/L，LDH 3251 U/L。

【诊断句】本例考虑冠心病、急性广泛前壁心肌梗死，Killip I 级。

【依据句】患者有长期吸烟史和劳力性胸痛史，1 天前胸痛加重并持续不缓解，伴大汗乏力；心电图 V1-V5 ST 段弓背向上抬高、Q 波形成、T 波倒置；心肌标志物 CK-MB 111 ng/mL、TnT 2348 pg/mL、CK 211 U/L、LDH 3251 U/L 升高，心脏彩超示前壁及前间壁运动减弱，支持急性心肌梗死。

【鉴别句】需与不稳定型心绞痛、心肌炎、肺栓塞、主动脉夹层等胸痛疾病鉴别。心肌梗死支持点为持续胸痛、ST 段抬高和心肌标志物动态升高；心绞痛通常心肌标志物不显著升高。

【补充检查句】建议动态复查肌钙蛋白、CK-MB、心电图，完善 NT-proBNP 评估心功能，必要时行超声心动图和冠脉相关检查。NT-proBNP <400 pg/mL 急性心衰可能性小，>1500 pg/mL 急性心衰可能性大。

易漏得分点：心肌标志物要会写“肌红蛋白最早，TnT 持续时间长，CK-MB 和 TnT 敏感性/特异性好”。

例 11 血气分析：重症哮喘由急性呼碱转急性呼酸 【题干速记】女，20 岁，急性呼吸重症哮喘，言语断续，不能完整说完一句话，持续吸氧。第一次血气：pH 7.53，PaO₂ 84 mmHg，PaCO₂ 28 mmHg，HCO₃⁻ 25 mmol/L。治疗 30 分钟后仍不缓解，面罩吸氧下复查：pH 7.34，PaO₂ 66 mmHg，PaCO₂ 48 mmHg，HCO₃⁻ 25 mmol/L。

【诊断句】第一次血气考虑急性呼吸性碱中毒；复查血气考虑急性呼吸性酸中毒，提示病情加重、通气衰竭风险。

【依据句】第一次 pH 7.53 升高、PaCO₂ 28 mmHg 降低、HCO₃⁻ 25 mmol/L 正常，符合急性呼吸性碱中毒；复查 pH 7.34 降低、PaCO₂ 48 mmHg 升高、HCO₃⁻ 25 mmol/L 正常，符合急性呼吸性酸中毒。由呼碱转为呼酸，结合重症哮喘、说话断续，提示呼吸肌疲劳和通气不足。

【鉴别句】需与代谢性酸中毒、代谢性碱中毒及混合性酸碱失衡鉴别。判断顺序为先看 pH 定酸碱，再看 PaCO₂ 和 HCO₃⁻ 判断呼吸性或代谢性，再用代偿情况和 AG 判断是否混合。

【补充检查句】建议完善血气复查、氧合指标、电解质、AG、乳酸，并结合临床呼吸状态动态评估。若数据和临床不一致，先核对标本和 Henderson-Hasselbalch/Kassirer-Bleich 规则。

易漏得分点：哮喘早期可过度通气出现呼碱；晚期 PaCO₂ 升高转呼酸是危险信号。

例 12 自身免疫：系统性红斑狼疮 【题干速记】女，27 岁，低热伴关节肿痛 3 个月，加重 1 周；胸闷、发热，口腔黏膜溃疡，四肢散在出血点。血常规：Hb 100 g/L，WBC 3×10⁹/L，PLT 50×10⁹/L。尿常规：血尿，尿蛋白 1 g/L。自身抗体：ANA 阳性，抗 dsDNA 抗体、抗 Sm 抗体阳性。胸片：双侧少量胸腔积液。

【诊断句】本例考虑系统性红斑狼疮（SLE）。

【依据句】患者为年轻女性，有低热、关节肿痛、口腔溃疡、皮肤散在出血点、胸腔积液等多系统受累表现；血常规 Hb 100 g/L、WBC 3×10⁹/L、PLT 50×10⁹/L，提示血液系统受累；尿常规血尿、尿蛋白 1 g/L，提示肾损害；ANA 阳性、抗双链 DNA 抗体阳性、抗 Sm 抗体阳性，其中抗 Sm 是 SLE 标记性抗体。

【鉴别句】需与类风湿关节炎、感染性疾病、血液系统疾病、其他自身免疫病鉴别。SLE 支持点为年轻女性、多系统受累、血液系统减少、肾损害和特异性自身抗体阳性；类风湿关节炎以关节受累为主，特异性抗体谱不同。

【补充检查句】建议完善补体 C3/C4、抗磷脂抗体谱、尿蛋白定量、肾功能、尿沉渣，必要时行肾脏病理以评估狼疮肾炎类型。

易漏得分点：SLE 主观题要写“多系统受累 + 多种自身抗体阳性”，不要只写 ANA 阳性。

例 13 肿瘤标志物：胰腺癌可能 【题干速记】女，55 岁，体检 B 超发现胰腺占位；肿瘤标志物结果为 PPT 图片，略。课堂答案提示 CEA、CA19-9 明显升高，NSE 也升高。

【诊断句】 本例考虑胰腺癌可能。

【依据句】 患者体检 B 超发现胰腺占位，肿瘤标志物中 CA19-9 明显升高，CEA 也升高，支持胰腺恶性肿瘤可能。CA19-9 是胰腺癌和胆管癌检出率较高的肿瘤标志物。

【鉴别句】 需与胆管癌、胰腺炎、胆汁淤积、急性肝炎、肝硬化等导致 CA19-9 升高的情况鉴别；CEA 也可见于结直肠癌、胃癌、肺癌等，并存在假阳性，不适合单独用于普查。

【补充检查句】 建议完善胸部及全腹部增强 CT，必要时结合 MRI/MRCP、EUS 或穿刺/手术病理确诊，并动态监测 CA19-9、CEA 评估病情。

易漏得分点：肿瘤标志物不能单独确诊肿瘤，必须结合影像和病理。

例 14 甲状腺功能：甲状腺功能亢进症 【题干速记】女，27 岁，心悸半月，心烦易激动、盗汗消瘦、多食，停经 55 天，尿 HCG(-)。心率 106 次/分，甲状腺 I 度肿大。甲功：TT3 5.19 nmol/L，TT4 243.6 nmol/L，FT3 18.4 pmol/L，FT4 74.4 pmol/L，TSH 0.014 μ IU/mL。甲状腺彩超：双侧叶对称性肿大、回声增强、血供丰富。

【诊断句】 本例考虑甲状腺功能亢进症。

【依据句】 患者心悸、心烦易激动、盗汗消瘦、多食，甲状腺 I 度肿大；TT3 5.19 nmol/L、TT4 243.6 nmol/L、FT3 18.4 pmol/L、FT4 74.4 pmol/L 升高，TSH 0.014 μ IU/mL 降低，符合甲状腺激素升高伴 TSH 抑制；甲状腺彩超示双侧对称性肿大、回声增强、血供丰富，支持甲亢。

【鉴别句】 需与垂体性甲亢、甲状腺炎、妊娠相关甲状腺功能变化、继发性甲减等鉴别。原发性甲亢常为 FT3/FT4 升高、TSH 降低；垂体性甲亢可表现为甲状腺激素升高但 TSH 不低。

【补充检查句】 建议完善甲状腺自身抗体，如 TRAb、TPOAb、TgAb 等，以判断是否为自身免疫相关并辅助判断预后；必要时结合甲状腺摄碘率或核医学检查。

易漏得分点：甲功题先看 TSH，再看 FT3/FT4；“T3/T4 $\uparrow$ + TSH $\downarrow$ ”优先想到原发性甲亢。

例 15 微生物培养 + 血药浓度监测：MRSA 肺炎，万古霉素谷浓度偏高并肾损害 【题干速记】男，65 岁，咳嗽咳黄脓痰 1 周余、发热 2 天。外院 WBC $12 \times 10^9/L$ ，N 78%；胸部 CT 示双下肺大片实变。痰培养提示耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）；万古霉素治疗后谷浓度 25 μ g/mL；肾功能：Cr 290 μ mol/L，BUN 17.6 mmol/L。既往糖尿病控制不佳，吸烟 40 年。

【诊断句】 本例考虑肺部感染，痰培养提示耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）感染；万古霉素谷浓度偏高，合并肾功能损害风险。

【依据句】 患者咳嗽咳黄脓痰、发热，WBC $12 \times 10^9/L$ 、N 78%，胸部 CT 示双下肺大片实变，痰培养提示 MRSA；万古霉素治疗后谷浓度 25 μ g/mL，高于 PPT 给出的 10–15 μ g/mL 范围，同时 Cr 290 μ mol/L、BUN 17.6 mmol/L 升高，提示需警惕肾毒性。

【鉴别句】 需与普通细菌性肺炎、污染痰标本、其他耐药菌感染鉴别。合格痰标本要求低倍镜鳞状上皮细胞 <10 个、WBC >25 个或比例符合要求；药敏 S 表示常规剂量可有效，I 表示加大剂量或药物浓缩部位可有效，R 表示耐药。

【补充检查句】 建议复查痰培养及药敏，必要时行血培养；监测万古霉素谷浓度、肾功能和尿量。万古霉素谷浓度应在再次给药前 30 分钟采集，监测目的为提高疗效并降低肾毒性。

易漏得分点：这题核心不是背治疗方案，而是写“培养标本合格性、药敏解读、TDM 意义、谷浓度与肾毒性”。

1.3 2. 高频检验组合速记

检验组合	最可能判断	主观题写法
Hb $\downarrow$ + MCV $\downarrow$ + MCH $\downarrow$ + MCHC $\downarrow$ + 血涂片小细胞低色素	小细胞低色素性贫血	“提示小细胞低色素性贫血，需进一步查铁代谢明确是否缺铁。”

检验组合	最可能判断	主观题写法
大便 OB(+) + 钩虫卵 (+) + 小细胞低色素贫血	钩虫慢性失血导致缺铁	“病因考虑钩虫导致长期慢性失血。”
WBC 显著 ↑ + 中性粒 ↑ + 核左移 + 中毒颗粒	严重细菌感染/类白血病反应	“需与慢性粒细胞白血病鉴别。”
PLT 单独显著 ↓ + 皮肤黏膜出血 + 脾不大	ITP	“需排除再障、白血病、DIC 和继发性免疫病。”
CSF 压力 ↑ + 细胞数 ↑ + 蛋白 ↑ + 糖 ↓	颅内感染	“需行脑脊液涂片、培养明确病原。”
ALT/AST ↑ + TBIL/DBIL ↑ + 蛋白 ↓	肝细胞性黄疸/肝功能损害	“提示肝细胞损伤，需结合乙肝标志物和影像。”
腹水比重低 + Rivalta(-) + 蛋白低 + 细胞少	漏出液	“支持门脉高压或低蛋白血症相关腹水。”
AFP >300 μg/L + 肝病背景	原发性肝癌可能	“需结合肝脏增强影像或病理。”
柏油样便 + FOBT(+++) + Hb ↓	上消化道出血	“需胃镜明确出血部位和病因。”
FBG ↑ + HbA1c ↑ + 尿酮(+++)	糖尿病酮症/DKA 可能	“需血气、AG、电解质确认是否酸中毒。”
Cr 孤立显著 ↑ + BUN/K/HCO3- 不配套	假性肌酐升高可能	“需考虑检测方法干扰，改用酶法复测。”
BUN ↑ + Cr ↑ + Hb ↓ + 双肾缩小	慢性肾功能不全/尿毒症	“支持慢性肾病进展并肾性贫血。”
CK-MB ↑ + TnT ↑ + ST 段抬高	急性心肌梗死	“需动态复查心肌标志物和心电图。”
pH ↑ + PaCO2 ↓ + HCO3- 正常	急性呼吸性碱中毒	“常见于过度通气，结合病史判断。”
pH ↓ + PaCO2 ↑ + HCO3- 正常	急性呼吸性酸中毒	“提示通气不足，急性期代偿不明显。”
ANA+ + 抗 dsDNA+ + 抗 Sm+ + 血尿/蛋白尿	SLE	“抗 Sm 为 SLE 标记性抗体，尿异常提示肾损害。”
CA19-9 ↑ + 胰腺占位	胰腺癌可能	“肿瘤标志物不能单独确诊，需影像和病理。”
TT3/TT4/FT3/FT4 ↑ + TSH ↓	原发性甲亢	“需查甲状腺自身抗体明确病因。”
痰培养 MRSA + 万古霉素谷浓度高 + Cr/BUN ↑	耐药菌感染 + TDM 异常	“需监测谷浓度和肾功能，结合药敏解释。”

1.4 3. 最后 20 分钟背诵版

1. 缺铁性贫血：小细胞低色素 + Hb 低 + MCV/MCH/MCHC 低 + 粪便钩虫/隐血阳性；补铁代谢和骨髓铁染色。
2. 类白血病反应：感染病史 + WBC 显著高 + 中性粒为主 + 核左移 + 中毒颗粒；鉴别慢粒。
3. ITP：皮肤黏膜出血 + PLT 单独明显低 + 脾不大；补血小板抗体、凝血、骨髓、免疫抗体。
4. 脑膜炎：CSF 压力高、细胞多、蛋白高、糖低；补涂片和培养。
5. 肝硬化腹水：肝病体征 + 肝功能异常 + 乙肝标志物阳性 + 漏出液；AFP 高要想肝癌。
6. 上消化道出血：柏油样便 + 隐血阳性 + 贫血；补胃镜。
7. DKA：高血糖 + 尿酮阳性 + 意识改变；补血气、AG、电解质。
8. 假性 Cr 高：Cr 高但 BUN/K/HCO3- 不配套 + 特殊暴露；用酶法复测。
9. 慢性肾炎尿毒症：蛋白尿/血尿 + BUN/Cr 高 + Hb 低 + 双肾缩小；蛋白尿多为肾小球性/混合性。
10. 心梗：持续胸痛 + ST 抬高 + CK-MB/TnT 升高；补 NT-proBNP 和动态心电图/标志物。
11. 血气：pH 定酸碱，PaCO2 定呼吸，HCO3- 定代谢，AG 查代酸，代偿判断混合。
12. SLE：年轻女性 + 多系统受累 + 血细胞减少 + 尿异常 + ANA/dsDNA/Sm 阳性。
13. 胰腺癌：胰腺占位 + CA19-9 高；不能只靠肿瘤标志物，需影像/病理。

14. 甲亢：T3/T4/FT3/FT4 高 + TSH 低；补甲状腺自身抗体。
15. TDM：万古霉素看谷浓度，谷浓度高疗效可能增加但肾毒性也增加；采血在下次给药前 30 分钟。